# 10.2.1. 전문의 임상권한 및 자격관리

| 제 정 일 | 2006.07. | 최 종 개 정 일 | 2025.03.25. | 최 종 검 토 일 | 2025.03.25. |
|---|---|---|---|---|---|
| 담 당 부 서 | 자격신임위원회 | | | | |
| 유 관 부 서 | | | | | |

| 관 련 기 준 | 4주기 의료기관인증기준: 10.2 의사(전문의)의 진료권한 승인과 평가<br>JCI Standard 7th Edition: SQE.9, 9.1, 10, 11, 12 |
|---|---|

제1조 (목적)

1. 임상학 교원, 진료교수, 임상강사의 자격 요건을 확인하고 임상권한을 체계적으로 승인 및 관리하여 환자안전과 의료의 질적 향상을 도모하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 임상권한: 병원 내 해당 임상진료에 대해 Authority를 부여하는 것으로, 허용된 진료 책임 영역의 범위를 말한다.
2. 대상: 임상학 교원, 진료교수, 임상강사
3. 임상권한 신청(갱신) 범위
   1) 독자 수행
   2) 감독하 수행: 임상권한 신청 후 갱신 시까지 임상과장 또는 지도교수의 관리 감독하에 진단, 시술·처치 및 수술 등을 수행하는 것을 의미한다. 관리 감독이란, 감독자가 전체 목표를 설정하고 피감독자가 업무를 수행하고 문제를 해결함에 있어 지속적으로 진행상황 등을 보고 받는 것을 의미한다.
   3) 신청 안함
4. 자격신임위원회
   1) 구성: 진료부원장(위원장), 진료혁신부원장(부위원장), 연구부원장, 기획관리실장, 교육수련부장, 진료협력센터소장, 내과부장, 외과부장, 진료혁신센터 1,2부센터장, 기획부실장, 환자안전팀장(간사)로 구성된다.
   2) 역할: 의사(전문의)의 자격 신임 및 자격 부여 등에 관한 사항을 심의

제3조 (절차)

1. 임상권한 정의서
   1) 임상권한 정의서에는 독자적 진료 수행 영역 및 진료 수행에 필요한 책임, 자격 요건, 필수교육 및 훈련 이수, 핵심 평가지표를 포함한다.
   2) 진료과별 임상권한은 3년마다 정기적으로 검토 및 재설계한다.
   3) 임상권한 정의서는 자격신임담당부서에서 관리한다.

2. 임상권한 신청
   1) 신청 시기

(1) 임상권한은 다음과 같은 경우에 신청한다.
① 신규 임용 시
② 재임용 시
③ 진료 책임 영역의 권한이 변경될 때
④ 새로운 진료행위 도입 등 신의료기술 또는 진료행위를 수행하기 위해 추가 권한이 필요한 경우
⑤ 진료 책임영역의 권한 변경이 없을 시, 대상자는 3년마다 임상권한을 갱신한다.

2) 신청 절차
(1) 대상자는 임상권한 신청 관련 학력, 졸업 후 수련경력, 면허, 자격 등 인사 관련 서류를 자격확인담당부서에 제출한다.
(2) 임상권한 갱신 대상자의 경우, 자격신임위원장은 진료임용 만기 90일 전에 갱신 절차를 안내한다.
(3) 임상권한 갱신 대상자는 안내받은 날로부터 30일 이내에 기존 제출 서류 외에 추가된 인사 관련 서류를 자격확인담당부서에 제출한다.
(4) 자격확인담당부서는 대상자가 제출한 서류에 대해 발급사실(Primary Source Verification)을 확인하고 행정시스템에 인사정보를 입력한다. 또한, 3년마다 면허상태를 재확인한다.
(5) 대상자는 본인의 인사정보가 정확한지 확인하고 입원권한, 환자진료 대상 연령군, 진료과별 임상권한 항목을 신청한다.
(6) 대상자는 임상권한 승인 과정에서 본인의 인사정보 및 임상권한 신청 내용을 검토하는 것에 동의한다.

3. 임상권한 승인
1) 승인 절차
(1) 해당 부서장(내과/외과부장 또는 임상과장)은 관련 인사정보 및 임상권한 신청 내용을 검토한 후 임상권한을 승인한다.
(2) 자격신임위원장에게 상정하여 검토 및 승인을 받는다.
(3) 세브란스 병원장이 최종 승인한다.
(4) 최종 승인 결과를 해당 부서장 및 대상자에게 알린다.
(5) 위 모든 절차를 임상권한 개시일 전에 완료한다. 단, 신규임용자의 자격검증이 완료되지 않았을 경우 해당 부서장(내과/외과부장 또는 임상과장)의 감독 및 책임하에 임시로 임상권한을 부여받을 수 있으며, 임상개시일 후 90일 이내에 임상권한 승인 과정을 완료한다.
(6) 재난 또는 응급상황 발생 시 승인된 임상권한 외에 필요한 의료 행위를 할 수 있으며, 이는 병원장의 결정 사항에 따른다.
(7) 재임용 및 임상권한 갱신 시 진료평가 결과를 반영한다.

4. 임상학 교원, 진료교수, 임상강사는 승인된 임상권한 범위 내에서 진료를 시행한다.

5. 임상권한 승인 결과에 이의가 있는 경우 자격신임위원회에 재심의를 요청할 수 있다.

6. 임상권한 변경
   1) 임상권한 신청 시기와 관계없이 임상권한 변경을 원하는 대상자는 자격신임담당부서에 연락하여 임상권한 신청 및 승인 절차를 진행한다.

7. 임상권한 제한
   1) 환자 또는 직원의 안전과 관련하여 임상권한 제한이 필요한 경우
      (1) 해당 부서장(내과/외과부장 또는 임상과장)은 [부록3. 임상권한 제한 요청서]를 작성하여 자격신임담당부서로 제출한다.
      (2) 자격신임위원회에서 관련 사항을 검토 및 심의한다.
      (3) 제출한 근거자료가 부족할 경우, 관련 서류를 추가로 요청할 수 있다.
      (4) 심의과정에서 필요 시 외부 자문을 진행할 수 있다.
      (5) 병원장이 최종 승인한다.
      (6) 최종 승인 결과에 대해 해당 부서장과 대상자에게 알린다.
   2) 진료평가 결과가 환자 또는 직원의 안전에 영향을 미친다고 판단된 경우
      (1) 자격신임위원회는 진료평가 결과를 해당 부서장 및 피평가자에게 알리고 재발방지 및 개선을 요청한다.
      (2) 재발 가능성이 높거나 개선이 어렵다고 판단한 경우, 자격신임위원회 심의 후 병원장 최종 결정에 따라 임상권한을 제한할 수 있다.

8. 임상권한 조회
   1) 조회 권한 및 방법
      (1) 관련 직원은 u-Severance를 통해 환자진료와 관련하여 임상학 교원, 진료교수, 임상강사의 전문진료 영역 및 해당 진료항목에 대한 임상권한을 확인할 수 있다.
      (2) 임상권한 조회를 거부하거나 임상권한이 없는 의사의 진료를 발견 또는 인지한 경우, 관련 직원은 이를 진료혁신센터 환자안전팀에 보고하고, 환자안전팀은 병원운영위원회에 보고한다.

9. 신의료기술 도입 시 임상권한 승인 절차는 세브란스병원 내규 [10.2.3. 신의료기술 도입 시 임상권한 승인]에 따른다.

10. 고난도/쟁점(Issue) 술기 임상권한
   1) 고난도/쟁점(Issue) 술기란 사회적, 의학적 논쟁이 되거나 일정 Training이 요구되는 술기로써, 해당 임상권한 부여는 [부록2. 임상권한 관리절차 가이드라인]에 따른다.

제4조 (부록)
1. 세브란스병원 자격신임위원회 운영내규
2. 임상권한 관리절차 가이드라인
3. 임상권한 제한 요청서

제5조 (참고)

# 내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년부터 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)